Algoritmo de decisión ante luxación/subluxación de LIO

Evaluación y manejo en urgencias y cirugía diferida

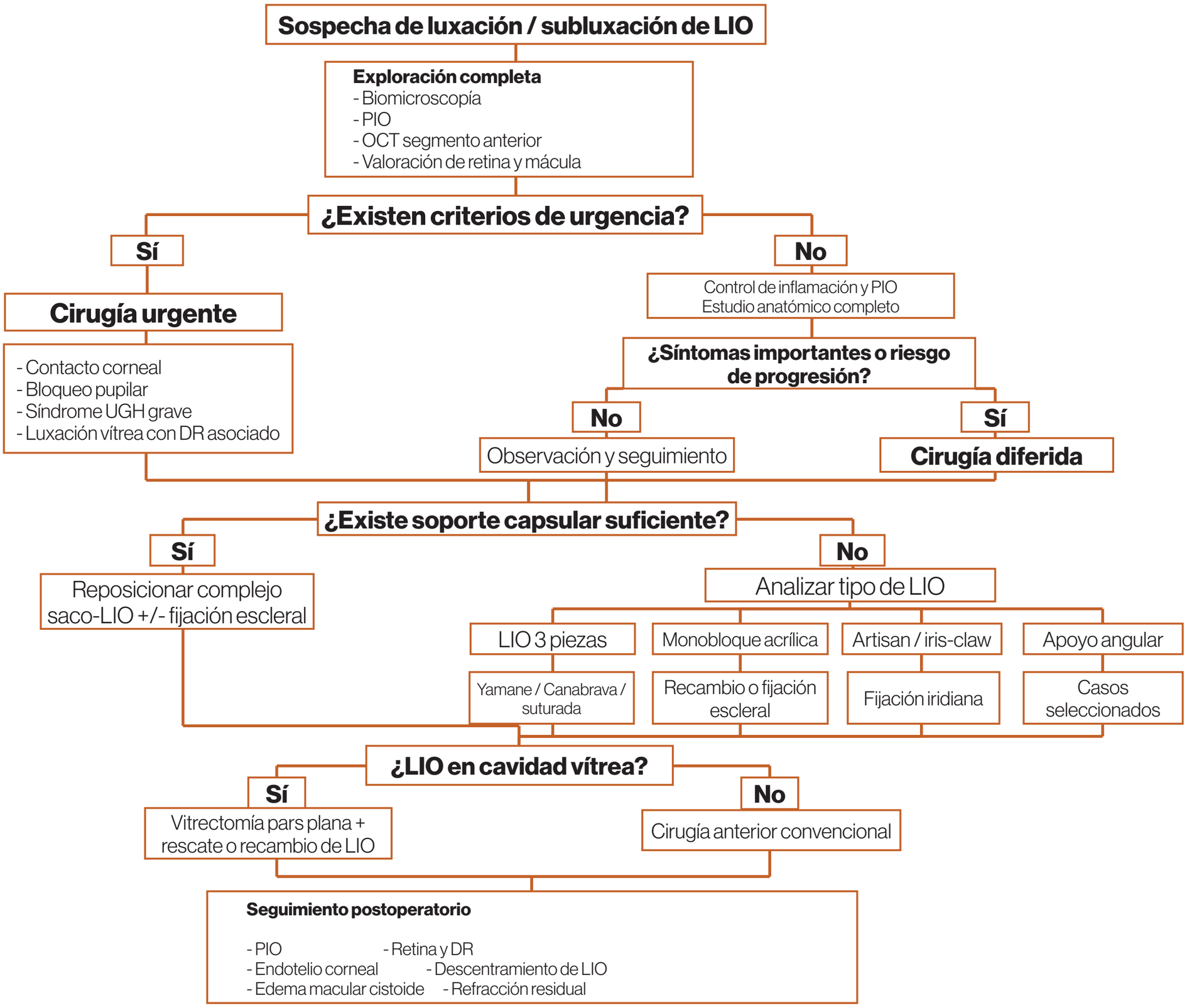


Figura. Algoritmo de decisión ante luxación/subluxación de lente intraocular.

INFLAMACIÓN POSTQUIRÚRGICA PRECOZ
Paciente operado de segmento anterior

¿12-48 h tras la cirugía?

NO

Sospecha de ENDOFTALMITIS
Iniciar protocolo de endoftalmitis:
- Toma de muestras
- Tratamiento antibiótico inmediato

SÍ

Valorar dolor y vitritis

¿Dolor intenso o vitritis?

SÍ

Sospecha de ENDOFTALMITIS
Iniciar protocolo de endoftalmitis:
- Toma de muestras
- Tratamiento antibiótico inmediato

POSIBLES SECUELAS
- Edema corneal persistente
  -> DMEK / DSAEK
- Glaucoma secundario
  -> Tratamiento hipotensor
  -> Cirugía filtrante si precisa

¿Existen otros casos operados en el mismo periodo?

SÍ

Investigar posible brote de TASS y notificar

NO

Seguimiento habitual

NO

Sospecha de TASS
- Reacción en cámara anterior
- Edema corneal blanco a blanco

TRATAMIENTO INMEDIATO
- Prednisolona acetato 1% cada 1-2 horas
- Control estrecho de la PIO
- Evitar prostaglandinas

Revisión en 24-48 h

¿Mejoría clínica?

SÍ

Mantener pauta y descenso progresivo de corticoides

NO

Revalorar diagnóstico diferencial
Considerar:
- Endoftalmitis
- Nuevo estudio etiológico